Allegato

Le indicazioni clinico diagnostiche di seguito riportate, come da parere del Consiglio Sanitario regionale:

a) Donne e uomini con sospetta osteoporosi secondaria derivanti da patologie quali:
- morbo di Cushing
- malassorbimenti intestinali
- malattie infiammatorie intestinali e resezioni intestinali
- ipogonadismo primitivo
- ipertiroidismo e iperparatiroidismo primitivo,
- epatopatie croniche specie se colestatiche
- insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefropatie croniche,
- soggetti sottoposti a trapianto

b) Soggetti che iniziano terapie prolungate (> 6 mesi) con :
- corticosteroidi sistemici (>5mg/die di prednisone -equivalenti),
- tiroxina ad alte dosi soppressive e non sostitutive,
- antiepilettici (fenitoina, fenobarbital),
- farmaci antiretrovirali,
- farmaci che inducono ipogonadismo,
- eparina

c) Donne in condizioni ginecologiche suggestive di carenza estrogenica :
- amenorrea primaria non trattata,
- ovariectomia bilaterale precoce,
- amenorrea secondaria di durata oltre 2 a a.,
- menopausa precoce (< 45 anni)

d) Donne in menopausa da almeno sei mesi , con fattori di rischio accertati, per le quali l'esecuzione dell'esame è a supporto della decisione terapeutica verso una terapia ormonale sostitutiva o altro trattamento per l' osteoporosi di lunga durata

I fattori di rischio considerati sono quelli legati all'anamnesi familiare, agli stili di vita e all'assunzione cronica di farmaci:
- Nutrizione: peso corporeo estremamente basso (ovvero Indice di Massa Corporea <19 kg/m2),
- Immobilità prolungata; fumo (> 20 sig/die); abuso di alcool (etilismo),
- Assunzione di Farmaci: vedi quelli indicati al precedente punto

e) Soggetti con evidenza radiologica di osteoporosi e di fratture correlate o con storia di pregresse fratture di tipo osteoporotico.

DENSITOMETRIA OSSEA

- La Densitometria Ossea è inserita dal DPCM 29/11/2001 nell'allegato 2B in quanto erogabile a carico del SSN solo secondo precise indicazioni cliniche basate su specifici criteri di appropriatezza.

- La DGR Toscana 1238/2003 ha individuato le indicazioni clinico diagnostiche che giustificano l'erogabilità della prestazione a carico del SSR , specificando inoltre che la richiesta da parte del prescrittore deve essere sempre motivata. (Allegato 1)

- La Regione Emilia Romagna nel 2002 ha individuato categorie di pazienti per i quali sono presenti evidenze di efficacia clinica per l'effettuazione dell'esame; tali categorie sono pressoché identiche a quelle individuate dalla DGR 1238 /2003 con la "sola" aggiunta della definizione della tempistica appropriata, stabilendo che "le densitometrie ossee di controllo successive al primo esame sono erogabili a carico del S.S.R. solo se eseguite con scansione temporale non inferiore ai 24 mesi".

- Le evidenze scientifiche in Letteratura confermano che: "in generale, l'esame densitometrico, se necessario, non dovrebbe essere ripetuto prima di 18 -24 mesi, perché le variazioni della massa ossea che eventualmente si verificano in tale intervallo di tempo possono essere inferiori all'errore di misurazione dello strumento diagnostico e perché il metabolismo naturale dell'osso necessita di tempi lunghi per poter registrare cambiamenti rilevanti " ed inoltre l'esame non deve essere usato come screening di massa e non è un esame "urgente" (Allegato 2).

- La valutazione densitometrica lombare è spesso poco accurata dopo i 65 anni per l'interferenza di osteofiti vertebrali, addensamenti artrosici, calcificazioni extrascheletriche. Per queste ragioni la valutazione della densità femorale può essere preferibile dopo questa età (Linee guida per la diagnosi, prevenzione e terapia dell'osteoporosi , SIOMMS 2006)

- Dato che l'esame densitometrico adopera radiazioni ionizzanti, quindi non scevro da potenziale rischio, è ad esempio possibile sostituire in molti casi, secondo l'evidenza clinica attuale, l'analisi dell'osso condotto con i raggi x con studio condotto con apparecchiature che usano ultrasuoni che come è noto sono privi di effetti dannosi. " L'indagine ultrasonografica, anche considerando i costi relativamente più bassi rispetto alla DXA, può essere raccomandata per uno screening di primo livello. " (Linee guida per la diagnosi, prevenzione e terapia dell'osteoporosi , SIOMMS 2006)

- Nella Regione Emilia Romagna uno studio che ha coinvolto 5 Aziende con un campione di 1375 casi prenotati nel periodo marzo -aprile 2002 ha evidenziato che l'83% dei pazienti sottoposti a MOC non presentava fattori di rischio e che il 41% delle richieste di MOC risultava inappropriato rispetto alle indicazioni cliniche.

- Da una disaggregazione dei dati del flusso SPA 2006 è emerso che pazienti ASF hanno effettuato presso AOUC oltre 47.000 MOC DXA per un importo totale lordo di € 1.510.000. Di questi pazienti il 18% era ultrasettantenne con casi di pazienti ultranovantenni.

CeVEAS

Centro per la Valutazione della Efficacia della Assistenza Sanitaria

LINEE GUIDA PER L'ACCESSO ALLA DENSITOMETRIA OSSEA

CRITERI DI ACCESSO alla Densitometria Ossea – PRIMO ESAME

USI APPROPRIATI

- **Donne in amenorrea post-menopausale da almeno sei mesi con fattori di rischio potenzialmente modificabili.**
- **Donne in menopausa in cui l'esecuzione dell'esame serva da supporto per decidere se instaurare una terapia ormonale sostitutiva di lunga durata**
- **Donne in menopausa precoce (prima dei 45 anni) che non assumono terapia ormonale sostitutiva o se questa è controindicata**
- **Donne e uomini con sospetta osteoporosi secondaria** (es. assunzione di corticosteroidi sistemici per malattie croniche per periodi di tempo prolungati (anni) eccetto coloro che assumono corticosteroidi topici per la terapia dell'asma; ipogonadismo; iperparatiroidismo, ecc.)

USI SUPERFLUI O NON APPROPRIATI

- **Donne in terapia ormonale sostitutiva**
- **Soggetti in terapia con alendronato**
- **Donne e uomini con osteoporosi già accertata**
- **Donne e uomini che assumono corticosteroidi topici per la terapia dell'asma**
- **Donne e uomini ultrasettantenni** dato che in questa fascia di età il valore predittivo dell'esame densitometrico è ancora più basso; inoltre, nel determinismo delle fratture in questa fascia di età entrano in gioco altri fattori importanti su cui intervenire (prevenzione delle cadute, adeguato supporto di calcio e vitamina D se la dieta è carente, incoraggiare una moderata attività fisica costante, ecc.).

CRITERI DI ACCESSO AI CONTROLLI DENSITOMETRICI - FOLLOW UP

Raccomandazioni Generali:

- **L'esame densitometrico non dovrebbe essere ripetuto prima di due anni**, perché le variazioni della massa ossea che eventualmente si verificassero in tale intervallo di tempo, non sono valutabili in quanto spesso inferiori all'errore di misurazione dello strumento diagnostico. **(grado B)**
- Un controllo densitometrico **non è raccomandato** a pazienti in terapia ormonale sostitutiva o in terapia con alendronato. **(grado B)**

Densitometria ossea (DEXA) COLONNA (prima dei 65 anni)			
	NORMALE Tscore > -1	OSTEOPENIA Tscore fra –1 e –2,5	OSTEOPOROSI Tscore al di sotto di –2,5
Controllo dopo	Di norma non necessario *	2 anni	Di norma non necessario *

* il controllo può essere eseguito in presenza di richieste motivate (per specifiche patologie, per diagnosi differenziali, variazioni del quadro clinico, ecc.).

Densitometria ossea (DEXA) FEMORE (dopo i 65 anni)			
	Zscore > 0	Zscore fra 0 e –1	Zscore < -1
Controllo dopo	Di norma non necessario *	2 anni	Di norma non necessario *